

TEMA 8.9 • NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

Convulsiones, Epilepsia y Estatus Convulsivo

PERFIL EUNACOM 1.10.1.011
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndromes Sensitivos: Polineuropatías y Neuropatías por Atrapamiento

Polineuropatía

- **Causa más frecuente: diabetes** (neuropatía diabética)
- Otras: déficit de B12/B1, autoinmune, genética (Charcot-Marie)

Clínica

TABLA 8.9.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	POLINEUROPATÍA	MIOPATÍA
Debilidad	Distal	Proximal
Sensibilidad	Alterada	Normal
Atrofia	Distal, marcada	Leve o hipertrofia

- Distribución "en guante y calcetín"** (peor lejos = en los pies → puede no sentir heridas → pie diabético)
- **Dolor neuropático:** urente (quemadura) + alodinia (dolor al roce) + hiperalgesia

Tratamiento

- Tratar la causa (control glicémico, vitamina B12)
- Cuidado de los pies (prevención pie diabético)
- Dolor neuropático: **gabapentina / pregabalina / amitriptilina**

Neuropatías por Atrapamiento

- **Estudio:** electromiografía (EMG) — enlentecimiento de conducción **solo en zona atrapada**
- **Tratamiento:** si causa tratable → tratar causa. Si no mejora → **cirugía de liberación**

TABLA 8.9.2: NEUROPATÍA VS NERVIO			
NEUROPATÍA	NERVIO	ZONA AFECTADA	CAUSA FRECUENTE
Túnel carpiano	Mediano	Dedos 1-4 (mitad radial del 4º)	Embarazo, DM, AR, HTA
Atrapamiento cubital	Cubital	Dedos 4-5 (mitad cubital del 4º)	Apoyo prolongado en codo
Meralgia parestésica	Femorocutáneo lateral	Cara lateral del muslo	Obesidad

Neuropatías por Compresión Aguda

TABLA 8.9.3: NOMBRE VS MECANISMO			
NOMBRE	MECANISMO	NERVIO	CLÍNICA
Parálisis del borracho	Se duerme sobre el brazo	Radial	No extiende muñeca ni dedos; ↓reflejo tricipital
Parálisis de luna de miel	La pareja duerme sobre el hombro	Plexo braquial	Extremidad superior completa (motor + sensitivo)

Neuralgias Post-herpéticas

- Complicación del herpes zóster
- Prevención: aciclovir o valaciclovir en las **primeras 48 h** del zóster
- Tratamiento: carbamazepina / gabapentina / pregabalina / amitriptilina

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 40 años presenta una crisis convulsiva que inicia con movimientos involuntarios de la mano derecha, seguido de pérdida de conciencia y posteriormente convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cómo se clasifica esta crisis y cuál es el estudio indicado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Convulsiones, Epilepsia y Estatus Convulsivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS
- Crisis focal (por lesión focal): RM/TAC con contraste + carbamazepina/fenitoína. Crisis generalizada (epilepsia/tóxico-metabólica): exámenes generales + EEG + ácido valproico/lamotrigina.
 - Si empieza focal y se generaliza = FOCAL (secundariamente generalizada). Solo las 5 clásicas son generalizadas.
 - Epilepsia primaria: diagnóstico con 2 crisis estereotipadas O 1 crisis + EEG alterado. Genéticas, autosómico dominante.
 - Anticonvulsivantes: monoterapia + ajustar por niveles plasmáticos antes de cambiar fármaco.
 - Convulsiones febriles benignas (5m-6a, buen estado): paracetamol + educación. Si aspecto tóxico → buscar meningitis.
 - Lorazepam EV para frenar crisis: 4 mg adultos, 0.1 mg/kg niños.
 - Convulsión febril compleja (focal, >15 min, ≥2/24h): agregar RM buscando tumor.
 - Estatus convulsivo: lorazepam + carga fenitoína → fenobarbital → anestesia general. Actuar de inmediato sin esperar 30 min.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONVULSIONES, EPILEPSIA Y ESTATUS CONVULSIVO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 40 años presenta una crisis convulsiva que inicia con movimientos involuntarios de la mano derecha, seguido de pérdida de conciencia y posteriormente convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cómo se clasifica esta crisis y cuál es el estudio indicado?

- A)** Generalizada tónico-clónica; electroencefalograma
- B)** Focal compleja secundariamente generalizada; resonancia magnética
- C)** Generalizada tónico-clónica; TAC sin contraste
- D)** Focal simple; exámenes generales
- E)** Crisis de ausencia; electroencefalograma

PREGUNTA 2

Niño de 3 años, previamente sano, presenta convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración en contexto de fiebre de 39°C. Se encuentra en buen estado general, sin signos meníngeos. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Punción lumbar para descartar meningitis
- B)** Resonancia magnética de cerebro
- C)** Educar a los padres, paracetamol y control SOS
- D)** Iniciar ácido valproico como anticonvulsivante
- E)** Hospitalizar y cargar fenitoína

PREGUNTA 3

Paciente de 50 años lleva 10 minutos convulsionando sin recuperar conciencia entre las crisis. ¿Cuál es el manejo inicial?

- A)** Esperar a que cumpla 30 minutos para iniciar tratamiento
- B)** Fenobarbital endovenoso
- C)** Lorazepam 4 mg EV + carga de fenitoína
- D)** Anestesia general con propofol
- E)** Diazepam oral + paracetamol

RESUMEN: CONVULSIONES, EPILEPSIA Y ESTATUS CONVULSIVO

Esta clase aborda las crisis convulsivas, la epilepsia, las convulsiones febriles y el estatus convulsivo. Las crisis se clasifican en focales (parciales simples o complejas, causadas por lesiones focales como tumores) y generalizadas (tónico-clónicas, mioclónicas, tónicas, atónicas y ausencias, causadas por epilepsia o alteraciones tóxico-metabólicas). Si empieza focal, es focal aunque se generalice secundariamente. El manejo difiere según el tipo: las focales requieren neuroimagen (RM o TAC con contraste) buscando lesión focal y se tratan con carbamazepina/fenitoína. Las generalizadas requieren exámenes generales (alteraciones tóxico-metabólicas) y EEG (epilepsia), tratándose con ácido valproico/lamotrigina (excepto tónico-clónica que usa fenitoína). Las epilepsias primarias son genéticas (autosómico dominante). El diagnóstico requiere 2 crisis estereotipadas o 1 crisis + EEG alterado. El tratamiento es monoterapia ajustada por niveles plasmáticos. Las convulsiones febriles se dividen en benignas (5 meses-6 años, buen estado general, manejo con educación y paracetamol) y con aspecto tóxico (sospecha de meningitis, requiere PL). Si son recurrentes se agrega diazepam con fiebre; si están convulsionando ahora, lorazepam EV (0.1 mg/kg en niños, 4 mg en adultos); si son complejas (focal, >15 min, o >2 en 24h), se pide RM. El estatus convulsivo (>30 min sin recuperación) se maneja escalonadamente: lorazepam → carga de fenitoína → fenobarbital → anestesia general.